

24 - 01-QCM Histologie Embryologie (Teams) - Pr. A. Fakhri

(0:07 - 1:22)

Alors, on va faire projeter des questions et vous répondez en écrivant des messages. Vous êtes là? Oui, monsieur. Voilà, vous commencez à répondre, s'il vous plaît.

(1:24 - 2:15)

Oui, monsieur. Donc, la première question, c'est ABD, donc ça ne pose pas de problème. Donc, il faut faire attention, s'il vous plaît, lorsqu'il y a un changement des propositions, des phrases au sein des propositions, il faut faire attention.

(2:16 - 2:53)

D'accord? Alors, on passe à la deuxième question. Alors, la deuxième, ça ne pose pas de problème. C'est aussi le B et le C, effectivement.

(2:54 - 4:08)

Allez, vous passez à la troisième. Alors, la troisième. Donc, je vais accepter qu'il dérive de macrophages.

(4:09 - 4:46)

Donc, on va l'accepter, même si c'est de la moelle osseuse, plus ou moins du macrophages, puisqu'il a un rôle qui est phagocyte. D'accord? Donc, les cellules de l'ongérence, c'est le B, le C et le E. Donc, les cellules étoilées au sein de la couche. Quelle couche? Au niveau de quelle couche de l'épiderme? Épineuse.

(4:46 - 4:51)

Très bien. Non, ce n'est pas la couche basale. C'est la couche épineuse.

(4:52 - 5:27)

Donc, c'est le B, le C et le E. Très bien. Alors, on passe à la quatrième question. Donc, c'est le A et le B. La mélanocyte se situe dans la couche basale.

(5:28 - 5:38)

Effectivement, elle élabore la mélanine. Ce sont des cellules qui sont visibles au microscope. Une cellule pour 35 kératinocytes.

(5:38 - 5:53)

Il ne contient pas de filaments de cytokératine, d'esmosomes. Ce sont les kératinocytes qui contiennent les filaments de cytokératine. Donc, le E, il contient des filaments de mélanine.

(5:53 - 6:12)

Pas de cytokératine, des grains de mélanine. Donc, le E, c'est le cytokératine qui contient au niveau de kératinocytes. Alors, la cinquième.

(6:28 - 6:54)

Donc, c'est le départ. Il existe deux types. Quels sont les deux types? Le crine et le mérocrine.

(6:54 - 6:59)

La même chose. Donc, le crine, c'est la même chose que le mérocrine. Très bien.

(7:08 - 7:34)

Donc, à propos de l'hypothélium de la face supérieure de la langue. Donc, ici. La sixième, d'abord.

(7:37 - 8:18)

Hypothélium de la face supérieure pour la sixième. Donc, elle est lisse et elle est pluristratifiée et pavémenteuse. Donc, ça c'est quelle face qui est lisse et qui est pavémenteuse et pluristratifiée? C'est quelle face? Inférieure.

(8:18 - 8:33)

Très bien. Donc, il est formé de papilles gustatives, dont les plus nombreuses, ce ne sont pas les papilles caliciformes. Alors, les papilles fongiformes sont présentes surtout au niveau de la pointe.

(8:33 - 8:46)

Oui, bien sûr, avec qu'on va goûter. Donc, je pense, fongiformes, elles participent au goût. Les papilles caliciformes, elles contiennent les bourgeons de goût.

(8:46 - 8:55)

Donc, avec les fongiformes. Alors, les bourgeons de goût sont situés dans la face latérale des papilles fongiformes. Très bien.

(8:55 - 9:11)

Donc, c'est le CDE. Monsieur? Oui? Monsieur, les papilles fongiformes, ce sont les plus nombreuses au niveau de la pointe? C'est les fongiformes qui sont les plus nombreuses. Oui,

monsieur.

(9:11 - 9:39)

D'accord, c'est les fongiformes. Donc, on passe à la septième. Alors, la muqueuse est oesophagien.

(9:39 - 9:50)

Son épithélium est pavémenteux et ratiné. La musculaire muqueuse est fine. Son épithélium est fait suite à celui de la cavité buccale.

(9:50 - 10:07)

Le coriandre comporte des glandes sur toute sa hauteur. La musculature comporte trois couches. Alors, c'est le B. La musculature est peu développée, donc elle est fine.

(10:08 - 10:14)

B, c'est son épithélium fait suite. Très bien. Donc, c'est le B et le C. Très bien.

(10:15 - 11:36)

Allez, on continue. Alors, la huitième question. Donc, c'est B, l'épithélium de surface.

(11:36 - 11:42)

Oui. L'osomiqueuse, non, ne comporte pas. La musculature est formée.

(11:42 - 12:10)

Très bien. Donc, ça ne pose pas de problème. C'est le B, D, E. Alors, la neuvième question.

(12:37 - 12:42)

Donc, pour la neuvième question. Ce sont des glandes endocrines. Se localisent.

(12:43 - 12:52)

Donc, le B, c'est oui. Donc, c'est le B et le E. Très bien. Donc, on continue.

(13:45 - 13:58)

Donc, c'est un épithélium qui est cylindrique simple. Il comporte les cellules caliciformes. Donc, c'est les deux propositions qui sont justes.

(14:04 - 15:48)

Alors, on passe. Donc, c'est le B, C, D, E. Très bien. Donc, il y a une face vasculaire et une face biliaire.

(15:49 - 16:02)

La face latérale intercellulaire, c'est la face biliaire. Et la face vasculaire, qui est la face en regard de l'espace de 10. Très bien.

(16:02 - 16:40)

C'est le B, C, D, E. Alors, l'espace de 10. Deuxième question. Donc, l'espace de 10.

(16:41 - 16:51)

Principalement, c'est les cellules d'héto et les fibres de réticuline. Donc, c'est le A et le D. S'il vous plaît, monsieur. Oui.

(16:52 - 16:58)

Est-ce qu'il y en a du sang au niveau de l'espace de 10? Non. Oubliez le sang. Le sang, ce n'est pas un élément.

(17:00 - 17:06)

Ce n'est pas... D'accord. C'est du sang. Mais ce n'est pas... Le sang, c'est vague.

(17:07 - 17:14)

D'accord. Donc, on parle des éléments qui sont les fibres de réticuline. Le sang, il est partout.

(17:14 - 17:16)

Même aux lumières des capillaires. Même partout. D'accord.

(17:17 - 17:23)

Donc, une fois le sang est en lumière, il passe dans l'espace de 10. Bien sûr. D'accord.

(17:24 - 17:32)

Mais... Monsieur. Oui. S'il vous plaît, et les cellules de cupes fer? Où sont-elles? Au niveau de la lumière des capillaires.

(17:35 - 17:37)

D'accord. Merci. D'accord.

(17:37 - 18:04)

C'est au niveau de la lumière des capillaires des cellules de cupes fer. Alors, la paroi rectale. Donc, lorsqu'on dit paroi rectale, c'est la même chose que la paroi colique.

(18:04 - 19:15)

Donc, il n'y a pas de différence. Alors, pour la treizième question. Donc, l'hypéthélium, il est cylindrique.

(19:15 - 19:29)

Simple. Oui. La muqueuse comporte des glandes tubuleuses alvéolaires.

(19:30 - 20:21)

Comment ils sont, les glandes? Comment ils sont, les glandes, au niveau du colon? La muqueuse colique. Tubuleuse. Très bien.

(20:21 - 20:53)

Tubuleuse simple. Donc, la musculaire muqueuse. Oui, Anès, tu veux parler? Qui veut parler? Donc, on a le A qui est juste et le C qui est juste.

(20:53 - 21:03)

Donc, la semiqueuse qui comporte un tissu conjonctif. Dans ce nom, elle est lâche. Effectivement, la musculuse, elle est formée de deux couches.

(21:03 - 22:17)

Donc, on revient à deux couches. Donc, c'est le A, le C et le E. Alors, le 14. C'est toujours Sarah qui répond.

(22:17 - 22:25)

Donc, parmi les caractéristiques. Donc, l'absence de cellules myoépithéliales. Oui, elles sont absentes.

(22:28 - 22:39)

La présence de cellules centroacineuses. Oui. Les grains de sécrétion de situation apicale.

(22:39 - 22:50)

Pas basale. Donc, une lumière qui est réduite. Et un pôle basale qui est basophile.

(22:51 - 23:23)

Très bien. C'est le A, B, D. Alors, passe au 15. Donc, branches lobaires, ce sont des branches.

(23:23 - 23:29)

Donc, ils ont les caractéristiques d'une branche, quelle que soit. Donc, ils possèdent un épithélium cilié. Oui.

(23:30 - 23:37)

Ils ne présentent pas de zone d'alvéolation. Le cartilage persiste sous forme des amas. Oui.

(23:38 - 23:46)

Ils ne se terminent pas par des bronchioles respiratoires. Effectivement, il fait suite aux branches souches. Donc, ça c'est simple.

(23:48 - 24:07)

Donc, la paroi alvéolaire. Donc, c'est très simple. Donc, ce n'est pas l'équivalent de la barrière R100.

(24:07 - 24:22)

Une partie de la paroi alvéolaire correspond à la barrière R100. C'est un tissu conjonctif recouvert de cellules épithéliales. De pneumocytes 1 et pneumocytes 2. Pas de cellules endothéliales.

(24:24 - 24:29)

Il n'est pas formé de fibres musculaires. Par contre, il est formé. Il contient des fibres élastiques.

(24:29 - 25:08)

Il est très riche en capillaires. Très bien. Alors, quels sont les éléments qui participent à la barrière R100? Donc, très bien.

(25:08 - 25:20)

C'est très simple. Donc, on a les voiles cétoplasmiques de pneumocytes 1. Avant, il y a le surfactant, bien sûr. Donc, il y a le surfactant.

(25:20 - 25:39)

Puis, voiles cétoplasmiques de pneumocytes 1. Puis, la lame basale qui va se fusionner avec la lame basale de cellules endothéliales. Puis, on a le prolongement cétoplasmique de cellules endothéliales. Très bien.

(25:39 - 25:59)

Donc, c'est le HCD. Alors, cellules endothéliales et cellules épithéliales. Les cellules endothéliales, ce sont des cellules épithéliales des vaisseaux.

(26:00 - 26:09)

On les appelle les cellules endothéliales. Tout simplement. D'accord? Alors, ces endothéliales, ce sont des cellules épithéliales des vaisseaux.

(26:09 - 26:42)

Des capillaires ou des vaisseaux sanguins. D'accord? Donc, ce n'est pas la même chose que les cellules épithéliales. Autres que les cellules pneumocytes 1 et pneumocytes 2. D'accord? Donc, 18.

(26:42 - 26:59)

Le problème qui va poser au 18, c'est la proposition B. Donc, l'épithélium est majoritaire du type respiratoire, bien sûr. Donc, sauf au niveau de vestibule où il y a des paviments stratifiés. Le chorion est riche en glandes.

(26:59 - 27:07)

Mycose, séromycose, moyenne séromycose, c'est la même chose. La région de vestibule est recouverte d'un épithélium pavimenteux stratifié. Oui.

(27:08 - 27:17)

L'épithélium olfactif est visible sur la partie supérieure des fosses nasales. Donc, oui. Alors, les cellules amicus sont nombreuses.

(27:18 - 27:28)

Effectivement, les cellules amicus sont nombreuses. L'épithélium olfactif est souvenir. La région, donc, le chorion est riche en glandes séromycozes, pas exclusivement mycozes.

(27:29 - 28:07)

Donc, ce sont des glandes qui sont mixtes. Donc, c'est le A, le C, le D et le E. Donc, à propos de la zone glomerulée de la cortico-surrénale. Donc, la zone cortico-surrénale est la couche la plus épaisse.

(28:07 - 28:18)

Non, la couche la plus épaisse, c'est la face succulée. Ce n'est pas de cordon fin, mais ce sont des glomerules. Donc, elles dérivent.

(28:18 - 28:38)

Donc, on a la medullose surrénale qui va se dériver de crête neurale. Et le reste, la cortico-surrénale, va se dériver de mesoblastes. Donc, ces cellules sécrètent les glucocorticoïdes.

(28:39 - 29:06)

Donc, la zone glomerulée, elle va sécréter quoi? Donc, le 19, c'est le C. Je suis d'accord. Donc, on passe au 20. Là, j'espère.

(29:06 - 29:47)

Très bien. Alors, le 20. Donc, les cellules parafolliculaires, effectivement, elles sont situées dans le côté basal des cellules folliculaires ou la thériocyte.

(29:48 - 30:01)

C'est une glande endocrine. Donc, les vesicules vont s'organiser au lobule incomplet. Effectivement, les thériocytes ou les cellules folliculaires possèdent des récepteurs à TSH.

(30:02 - 30:11)

Et les follicules, bien sûr, elles sont bordées par un épithélium qui change la hauteur selon l'activité. Donc, soit cubique, soit aplati simple. Très bien.

(30:11 - 30:29)

Donc, toutes les propositions sont justes. Très bien. Donc, on passe au 21.

(30:32 - 30:40)

Oui, les lobules sont incomplets, effectivement. Ce ne sont pas des lobules complets. Au niveau de la thyroïde, ce sont des lobules incomplets.

(30:51 - 30:59)

Ça veut dire lobules incomplets. Ça veut dire que le lobule n'est pas complètement entouré par un tissu conjonctif. Donc, il y a des septa.

(30:59 - 31:12)

Mais, un côté, on n'aura pas de septa. On parle de lobules incomplets. Donc, ici, je pense que vous connaissez bien la cortico-surrénale.

(31:13 - 31:22)

Ils s'organisent en trois zones. La zone glomerulée, fasciculée et réticulée. La zone glomerulée, ce n'est pas la plus importante.

(31:22 - 31:33)

Ce n'est pas la plus épaisse. Effectivement, il y aura un tissu conjonctif qui est très, très lâche, qui est peu abondant. Effectivement, on aura des capillaires de type fenêtré.

(31:33 - 31:44)

Donc, l'épithélium, il est perforé, mais la membrane basale, elle est continue. C'est la caractéristique de tout ce qui est endocrinien. Et, il est entouré par une capsule fibreuse.

(31:45 - 31:50)

Donc, effectivement, c'est le ACDE. Très bien. Alors, on passe 22.

(32:06 - 32:15)

Donc, le 22, ça pose aussi pas de problème. On connaît les îles de L'Angélin. Ils constituent 1% presque, donc, de parenchymes pancréatiques.

(32:16 - 32:32)

Effectivement, c'est la régulation de la glycémie. Donc, si les cellules qui élaborent l'insuline sont périphériques, non. Alors, les cellules qui élaborent le glycogon sont des cellules alpha.

(32:32 - 32:48)

Alors, elles constituent le pancréas endocrine. Très bien. C'est le B et le E. Donc, à propos des cellules endocrines de tube digestif.

(33:01 - 33:16)

Donc, elles sont situées dans la région profonde de la glandouille, toujours. Elles sécrètent une hormone qui est localisée au pôle basal, pas apical. Elles déversent directement leurs produits dans les capillaires sanguins du coriandre.

(33:18 - 33:28)

Elles sont bien visibles, non. Elles ne sont pas bien visibles au microscope optique de coloration. Donc, on va utiliser l'immunohistochimie et ce n'est pas la coloration de trichrome.

(33:29 - 33:46)

Effectivement, elles sont nombreuses au niveau de l'entrée gastrique. Donc, on voit bien que dans l'estomac, il y a beaucoup de cellules endocrines au niveau de l'entrée gastrique. Alors, 25.

(34:09 - 34:36)

Ah, un signal 24, oui. 24. Donc, pour le 24.

(34:40 - 34:49)

Alors, les cellules principales, ce sont des cellules de grande taille polygonale. Non. Donc, ce ne sont pas de grande taille polygonale.

(34:50 - 35:10)

Comment on les appelle? Ils sont de très grande taille. Comment on les appelle au niveau de la parathyroïde? Oxyphile. Très bien.

(35:15 - 35:22)

Donc, elles élaborent la parathyroïde. Effectivement. Très bien.

(35:25 - 36:23)

Est-ce qu'elles ont un cytoplasme basophile? Elles sont des cellules les plus nombreuses de la parathyroïde. Elles sécrètent la calcitonine. Donc, effectivement, elles élaborent la parathyroïde.

(36:23 - 36:32)

Et elles sont des cellules les plus nombreuses de la parathyroïde. Donc, elles ne sécrètent pas la calcitonine. Très bien.

(36:32 - 37:00)

Donc, concernant maintenant la trempe utérine. Donc, pour le 25. Concernant la trempe utérine, sa lumière est bourdée par un épithélium où les cellules non ciliées sont les plus nombreuses.

(37:01 - 37:12)

Donc, c'est le contraire. C'est les cellules ciliées qui sont nombreuses. La semiqueuse ne contient rien.

(37:14 - 37:28)

Ce tissu, il n'y a pas de semiqueuse généralement. Donc, la lumière de la trempe est plus large, pas au niveau de l'isme. Effectivement, elle permet la migration des spermatozoïdes.

(37:30 - 37:41)

Donc, ce n'est pas la partie ismique qui est située dans la paroi utérine. C'est ce qu'on appelle l'interstice ou l'entraôle. Donc, c'est la proposition T qui est juste.

(37:44 - 38:20)

Alors, on passe au 26. Alors, pour le 26. Donc, le 26, ça commence par se différencier la tunique interne et externe.

(38:21 - 38:25)

On aura les cellules folliculaires. Elles forment deux couches au plus. Donc, deux.

(38:25 - 38:52)

Donc, la membrane de Slavinsky, elle n'est pas entre l'ovocyte et la granulosa. Comment on appelle entre l'ovocyte et la granulosa? Comment on appelle cette zone? Très bien. Alors, l'ensemble des cellules, on les appelle les cellules de granulosa.

(38:52 - 39:38)

Ça ne pose pas de problème. Alors, on passe à propos du corps utérin. Donc, ici, le 27 est simple aussi.

(40:06 - 40:19)

Donc, AB, très bien. Donc, ça ne pose pas de problème. L'endomètre subit des variations selon le cycle.

(40:19 - 40:24)

La musculuse est la couche la plus épaisse. La partie spongieuse ne persiste pas. Elle va disparaître.

(40:25 - 40:35)

Donc, la seule qui va rester, c'est la partie basale. Le 27 est formé d'une partie qui est dilatée, une partie qui est cylindrique. Son épithélium, il va s'invaginer.

(40:35 - 41:05)

Effectivement, c'est le AB2. Donc, concernant la glande mammaire. Donc, ce n'est pas une glande, donc ça ne pose pas de problème.

(41:06 - 41:22)

C'est une glande exocrine, tubulale, veillolaire. Donc, les lobes, c'est plus grand, sont séparés par un tissu conjonctif qui est plus ou moins dense. On distingue une dizaine de lobes par glande mammaire.

(41:25 - 41:42)

Et le tissu conjonctif, qui est paléale, est un tissu conjonctif qui est intra- ou interlobaire. Je ne me rappelle pas. Il faut vérifier.

(41:43 - 41:50)

C'est l'intralobulaire. L'intralobulaire, très bien. Très bien.

(41:51 - 42:02)

Donc, à propos de l'épithélium alpiguien. Vous connaissez maintenant l'épithélium alpiguien, ça ne pose pas de problème. Ou l'épithélium de l'endocolle, ou de l'exocolle.

(42:03 - 42:29)

Donc, l'exocolle, vous le connaissez. L'endocolle, vous le connaissez. Donc, c'est ADE.

(42:29 - 42:42)

Donc, on l'observe au niveau du vagin et au niveau de l'exocolle, pas l'endocolle. Donc, l'endocolle, c'est un épithélium qui est cylindrique, simple. Les cellules de la couche la plus profonde, non.

(42:42 - 42:55)

Elles ne sont pas volumineuses polyhydriques. Les cellules s'aplatissent, c'est la définition d'un épithélium alpiguien. Et effectivement, on parle d'un épithélium qui est pavimenteux, stratifié, non kératinisé.

(42:55 - 43:24)

Donc, alpiguien, kératinisé ou non. On passe un petit peu à l'appareil génital masculin. Donc, les cellules de sertolie.

(43:26 - 43:57)

Donc, ce sont des cellules qui sont non germinales. Qu'est-ce qu'ils élaborent, les cellules de sertolie? Qu'est-ce qu'ils produisent? Elles élaborent l'ABP, l'androgène benzène protéine et l'hormone antimullérienne. Très bien, c'est l'hormone antimullérienne, surtout.

(43:57 - 44:06)

Donc, assure la maturation des gamètes. Oui. Se localise au niveau de l'épithélium des tubes séminifères.

(44:06 - 44:12)

Oui. Donc, c'est là. Donc, il n'y a pas de stériocyle au niveau du pôle apical.

(44:13 - 45:03)

Donc, c'est au niveau du stériocyle. Ça commence à quel niveau, le stériocyle? Donc, continue. Donc, le tissu interstitiel.

(45:37 - 45:40)

Ah, oui. OK. Toutes les propositions sont justes.

(45:40 - 45:51)

Je suis d'accord. Donc, le tissu interstitiel, c'est un tissu conjonctif ordinaire. Donc, il va renfermer tous les éléments du tissu conjonctif ordinaire.

(45:51 - 45:57)

Plus, on aura les cellules de l'aïdique. D'accord. Donc, c'est très simple.

(45:59 - 46:15)

Fibroblastes, lymphocytes, vaisseaux, macrophages, tout ça, ce sont des éléments qui composent un tissu conjonctif. Plus les cellules de l'aïdique qui sont des cellules endocriniennes. Alors, on passe à 32.

(47:11 - 47:25)

Très bien. Donc, il est traversé, ce n'est pas une glande amphicrine, c'est une glande qui est exocrine. Traversée effectivement par le canal éjaculateur, elle est entourée par une capsule qui est fibreuse.

(47:25 - 47:31)

On dit capsule conjonctif, capsule fibreuse. Conjonctif, c'est fibreuse. C'est la même chose.

(47:32 - 47:43)

Donc, elle n'élabore pas de testostérone et elle renferme effectivement des glandes. Monsieur, on a vu dans le cours qu'il est fibroélastique. Ça veut dire fibreuse.

(47:44 - 47:55)

Ce n'est pas une conjonctive fibreuse. Lorsque je dis fibreuse, ça veut dire que ça peut renfermer aussi les fibres élastiques ou la fibre élastique. Donc, on peut l'accepter comme juste, monsieur Mouchkine.

(47:56 - 48:01)

D'accord ? D'accord, monsieur. Non, fibreuse, ça c'est très détaillé comme ça. Il y a une conjonctive.

(48:02 - 48:34)

Ce n'est pas adipeuse, ce n'est pas... D'accord ? C'est fibreuse, conjonctive, on peut l'accepter. Pas de problème. Alors, à propos de cellules de Leydig, donc c'est très simple.

(48:34 - 48:44)

Assure fonction endocrine. Ce sont des cellules de grande taille, nucléol bien visible. Elles synthétisent le testostérone, pas l'hormone antimüllérienne.

(48:44 - 48:51)

Donc, elles sont situées au niveau du tissu conjonctif. Très bien. On passe à l'organisation du rein.

(49:19 - 49:22)

Très bien. C'est le ADE. Ça ne pose pas de problème.

(49:23 - 49:59)

Alors, on passe. 35. Donc, la chambre urinaire est faite suite au tube contourné proximal.

(49:59 - 50:08)

Les capillaires glomerulaires forment des onces entourées des peaux de citouilles. Les pédicelles podocytes sont riches. Très bien.

(50:08 - 50:19)

Les feuilles viscérales sont formées de podocyte. Très bien. L'endothélium capillaire est de type continu et qui se repose sur une lame basale qui le sépare.

(50:20 - 50:23)

Donc, il y a deux types. Il y a du type feu nétré. Très bien.

(50:37 - 51:10)

Alors, 36. Donc, c'est le B. Elle est juste. Le C. Elle est juste.

(51:16 - 51:29)

Donc, les cellules de l'hépéthélium, il devient haute. Tout simplement, il ne comporte pas d'ostréation. Les cellules de la C sont des cellules mesongiales extra-glomerulaires.

(51:30 - 51:49)

Très bien. À propos des voies exsécritrices urinaires. Donc, ça, c'est, on pense, on a déjà vu ça.

(52:13 - 52:33)

Donc, le 37. Donc, effectivement. Donc, très bien.

(52:33 - 52:38)

Bravo, les filles. Allez, on passe. 38.

(53:08 - 53:24)

Donc, 38. Donc, tube contourné proximal. Effectivement, FES-8, il a une lumière qui n'est pas large.

(53:26 - 53:42)

Pôle apical, il renferme une bordure en brosse. Limites intercellulaires sont invisibles. Il se continue par l'ence dans les.

(53:42 - 53:46)

Très bien. On passe. 39.

(54:01 - 54:13)

Donc, embryo, c'est presque la même chose chaque fois. Il est constitué de blastèmes metanéphrogènes situés dans la région. Donc, région sacrée, présacrée, c'est la même chose.

(54:13 - 54:18)

Ce n'est pas un grand problème entre les deux. On peut les considérer sacrées, présacrées. C'est juste.

(54:18 - 54:31)

Le bourgeon érythérique correspond effectivement à excréteur. Le blastème metanéphrogène donne naissance aux unités qui s'écrètent. Elle n'est pas réglementaire.

(54:32 - 54:36)

Donc, le B, elle est juste. On peut sacrer, présacrer. C'est la même chose.

(54:41 - 54:55)

Alors, on passe à 40. Donc, malformation du système urinaire. Je pense que vous le connaissez.

(54:57 - 55:06)

Polykystose. Tout ce qui est anomalie de position, l'ectopie. La génésie, l'absence, le développement.

(55:07 - 55:15)

Et le cyanisme de l'oracle. Tout ça, c'est le système urinaire. Donc, cryptorchidie, c'est tout ce qui est génital.

(55:18 - 55:26)

Donc, on peut avoir une ectopie au niveau des voies urinaires. L'ectopie dura. Donc, le P, elle est juste.

(55:29 - 55:46)

D'accord? Le P, elle est juste pour le 40. C'est le A, le P, le C et le E. Cryptorchidie, c'est une anomalie de position du testicule, mais dans un trajet de descente du testicule. Donc, il est moins grave que l'ectopie testiculaire.

(55:51 - 56:03)

Donc, le développement du testicule. Donc, ça, c'est une règle qu'on connaît. Pour développer le testicule avant, dans le stade indifférencié, il y aura les cordons primitifs qui se développent.

(56:03 - 56:26)

Puis, selon le sexe, est-ce que c'est masculin ou féminin? Donc, cortical pour les mains féminins, médulaire pour le masculin. Donc, on aura le A, le P, le C et le E, bien sûr, l'apparition de l'albuginée et l'apparition des cordons corticaux. C'est le développement de sexe féminin.

(56:29 - 56:36)

Très bien. Alors, 42. Donc, on connaît ça, le canal du mulaire et le canal du wolf.

(56:37 - 56:47)

Donc, le canal du mulaire, il persiste sur le sexe féminin. Donc, le canal du wolf, il va disparaître. Donc, il va donner tout ce qui est voie génitale.

(56:48 - 57:00)

Donc, il va donner les trompes, le corps et le col utérin. Ça ne pose pas de problème, mais la partie supérieure du vagin. Alors, le wolf, au contraire, c'est le masculin qui va se développer.

(57:00 - 57:11)

Elle va donner les voies génitales masculins. Donc, le canal déférant, l'épididyme, le canal éjaculatoire. Donc, il ne va pas donner le prostate, bien sûr.

(57:18 - 57:40)

Très bien. Donc, 44. Donc, toutes les malformations qu'on peut avoir, utérus, bicorps, la trisomie du col, la trisomie du vagin.

(57:41 - 58:15)

Donc, le cryptorchidisme, c'est le sexe masculin et l'hernie ombilicale, c'est le développement du tube digestif. Donc, 45, l'intestin primitif moyen. Donc, le moyen, c'est à partir de la partie terminale du diauténom jusqu'à le colon.

(58:16 - 58:33)

Une partie du colon transverse, la majorité du colon presque transverse. Donc, ça va donner le jeugénom, le sécomme, le papas, donc, c'est le C et le T. Très bien. Donc, le reste, c'est le postérieur qui va donner le rectum, effectivement.

(58:35 - 58:59)

Il va donner le colon descendant, très bien, et le colon sigmoïde. Et ce n'est pas la partie inférieure du canal anal, c'est la partie supérieure du canal anal. Très bien.

(59:06 - 59:40)

Alors, parmi les malformations de l'intestin primitif moyen. Donc, on parle maintenant du moyen. Donc, le moyen, il peut donner, on connaissait l'omphalocele avec... Donc, c'est une... Très bien, il y a l'omphalocele.

(59:41 - 59:59)

Donc, il prend, on peut le voir. Donc, la triside de l'œsophage, c'est l'intestin antérieur. Qu'est-ce de l'oraque? C'est la malformation de quelle partie? C'est urinaire et les kystes mésantériques, kystes ontero-mésantériques.

(59:59 - 1:00:24)

Il n'y a pas de kystes mésantériques seule. C'est juste ou fausse? Là, il est fausse, mésantérique. Seule, non.

(1:00:24 - 1:00:48)

Ce n'est pas mésantérique seule. Mésantère, rien à voir avec le tube digestif. Alors, 48, ça c'est d'une façon générale, l'embryologie.

(1:00:49 - 1:01:00)

La paroi du tube digestif. Tout ce qui est ondo. Et tout ce qui est, effectivement, tout ce qui est ondo.

(1:01:01 - 1:01:10)

L'ondo, l'ondoblaste, l'ondoderme, c'est la même chose. Presque tonera. Tout ce qui est hypothélium.

(1:01:10 - 1:01:17)

Tout ce qui est glandes. Est-ce qu'il va donner le chorion? Non. Il va donner les glandes du chorion, oui.

(1:01:17 - 1:01:25)

Il ne va pas donner le chorion. Le chorion, c'est un tissu conjonctif. Le mésoblaste, effectivement, il donnera tout ce qui est muscles.

(1:01:25 - 1:01:36)

Les crêtes norales, ils vont donner tout ce qui est plexus, oui. L'ectoblaste, oui, c'est l'ecto. C'est la partie inférieure du canal anal, comme la peau.

(1:01:37 - 1:01:42)

Et le mésoderme, c'est le mésoblaste aussi, il va donner les vaisseaux sanguins. Très bien. C'est le BCDE.

(1:01:42 - 1:02:14)

Très bien. Les malformations de l'intestin postérieur. Alors, pour le 49.

(1:02:16 - 1:02:25)

Donc, on accepte qu'il y a la trisie anorectale, du verticule de Merkel, mégacolon, congénital. Ça, c'est le moyen. Gastro-cystules ont phénomènes ontériques.

(1:02:26 - 1:02:31)

Donc, ça, c'est tout ce qui est moyen. OK. Alors, la partie céphalique.

(1:02:33 - 1:03:04)

Donc, la partie céphalique, ça veut dire c'est la partie supérieure, on peut dire, de l'intestin primitif antérieur. Alors, qu'est-ce qu'il va donner, la partie céphalique? Je pense que ça, c'est très bien. Donc, le pharynx et le fond de la cavité buccale.

(1:03:05 - 1:03:11)

Très bien. Donc, ça pose pas de problème. Très bien.

(1:03:15 - 1:03:35)

Alors, est-ce que vous avez des questions? C'est pas la peine. Monsieur? Oui? S'il vous plaît, la définition. La définition.

(1:03:49 - 1:05:07)

Monsieur, s'il vous plaît, la définition du... Alors, vous avez des questions? Monsieur? Oui? Est-ce que le tube contourné proximal fait suite à la chambre urinaire? J'ai pas compris cette partie. Bien sûr, fait suite. Après la chambre urinaire, c'est le tube contourné proximal.

(1:05:07 - 1:05:20)

Monsieur, j'ai pas compris la différence entre... Comment... C'est pas le glomérule, c'est la chambre urinaire. Est-ce que... Donc, la chambre urinaire, il fait partie du glomérule. C'est une partie du glomérule.

(1:05:21 - 1:05:31)

C'est le vide. Il y aura déversement de l'urine primitive. Cette urine primitive, elle va passer dans la chambre urinaire.

(1:05:31 - 1:05:45)

D'accord? Et cette chambre urinaire, la suite de la chambre urinaire, c'est le tube contourné

proximal. D'accord? D'accord. Le glomerule, une partie du glomerule qui est à l'intérieur, c'est la chambre urinaire.

(1:05:46 - 1:06:19)

D'accord? D'accord. Monsieur? Oui? S'il vous plaît, est-ce qu'un épithélium malpighien, est-ce qu'il peut être kératinisé et non-kératinisé? Ou il est toujours non-kératinisé? Yes. Mais tout à l'heure, il y avait une proposition sur pourquoi l'épithélium malpighien est non-kératinisé.

(1:06:19 - 1:06:26)

On a dit que c'était vrai. Oui, il est non-kératinisé, mais là-bas, il y en a deux qui sont kératinisés. Il y en a deux.

(1:06:26 - 1:06:31)

Il y a un malpighien kératinisé. D'accord? D'accord. Merci.

(1:06:32 - 1:06:41)

D'accord? Oui. Donc, il peut être malpighien kératinisé, il peut être non-kératinisé. D'accord, merci.

(1:06:46 - 1:07:24)

Alors, l'épithélium de type proximal, est-ce qu'il est cubique simple ou cylindrique simple? Donc, je pense que c'est du cubique simple. Donc, mes amis, je me n'aime bien. D'accord? Donc, l'examen TP, il n'y a rien de grave.

(1:07:24 - 1:07:41)

Donc, l'essentiel, d'abord, concentrez-vous, s'il vous plaît, pour la préparation de l'alcool. D'accord? Et l'histoire, tous les exemples des examens, quand je pense toujours, il y aura des différences. Quelques différences.

(1:07:42 - 1:08:01)

Mais la charpente, elle est toujours la même. Merci beaucoup, monsieur. C'est la fin de l'année.

(1:08:01 - 1:08:12)

D'accord? Je sais que ce n'est pas une année facile. Mais, incha'Allah, vous allez reprendre, incha'Allah, bientôt. Incha'Allah.

(1:08:12 - 1:08:35)

D'accord? C'est très simple. on ne posera jamais de problème, incha'Allah. D'accord? Je pense

que vous avez mon numéro.

(1:08:35 - 1:08:42)

Vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez un problème, vous m'appellez.

(1:08:44 - 1:08:49)

D'accord? J'espère que vous aurez une année joyeuse. Bonne année. Incha'Allah.

(1:08:50 - 1:08:56)

A bientôt, incha'Allah. Bienvenue. Donc, peut-être que nous allons vous voir le lendemain de l'examen.

(1:08:56 - 1:08:59)

Ce n'est pas un problème. Peu importe le confinement. Nous allons vous voir le jour de l'examen.